Délai de réalisation de la césarienne en urgence au Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya (CHUR-OHG)

Nom du présentateur : Dr OUEDRAOGO Issa MCA en gynécologie-obstétrique

Auteurs et coauteurs : Sib S R, Sanogo M, Kiemtore S, Kabore U, Millogo/Traore TDF

Affiliations : Université Lédea Bernard OUEDRAOGO (ULBO)

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Délai de réalisation d'une césarienne en urgence a un impact sur le pronostic fœtal avec recommandations qui sont floues.
- Délai influencé par plusieurs facteurs dépendant ou indépendant du système d'administration des soins.
- Lucas D. N donne classification selon code de couleur, degré d'urgence des interventions césariennes : rouge , orange, vert

Objectif

Evaluer le délai de réalisation de la césarienne en urgence dans le service de gynécologie-obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire Régional de Ouahigouya du 19 août au 19 novembre 2024.

Matériel et méthode(s)

- Etude transversale prospective à visée descriptive et analytique allant du 19 août au 19 novembre 2024 dans le service de gynécologie-obstétrique du CHUR-OHG
- Population étude était constituée des femmes enceintes qui ont été reçues et /ou hospitalisées dans le service durant période étude

Matériel et méthode(s)

- Ont inclus, toutes femmes enceintes chez qui l'indication une césarienne a été faite en urgence au sein du service de gynécologie-obstétrique durant notre période d'étude
- Taille de l'échantillon N a été obtenue par la formule de Lorenz.

$N = (z)^2 p(1-p) / d^2$, soit 282

Matériel et méthode(s)

- Données ont été saisies et analysées sur micro-ordinateur à l'aide de logiciels Microsoft WORD 2019® et EPI-INFO® version 7.2.5.0
- Graphiques ont été réalisés avec logiciel Microsoft EXCEL® 2019
- Préservation de anonymat dans processus de collecte, de traitement et de diffusion des données a été assurée.

Résultats

- Fréquence

Les césariennes en urgence ont constitué 28,69 % (soit 282 sur 1486 accouchements)

Résultats

- Caractéristiques socio-démographiques

  - Age moyen patientes était dans 25,96 ± 6,78 ans avec des extrêmes de 16 et 45.
  - Vie maritale 97,52%
  - Non scolarisées dans 65,60%
  - Femmes au foyer dans 86,52%

Résultats

- Classification de césariennes selon le code couleur

  - Césariennes code rouge ont représenté 54,26 %,
  - code orange 4,61 %
  - et code vert 41,13 % des indications

Résultats

- Indications des césariennes

  - Code rouge (n=116) : bradycardie fœtale (42,24%), suspicion de RU (11,21%), suspicion HRP (9,48%)
  - Code orange (n=13): anomalie RCF (92,31%), échec ventouse (7,69%)
  - Code vert (n=153): Présentation dystocique, césarienne prophylactique en travail (27,45% respectivement), défaut engagement (19,61%)

Résultats

❑ Réalisation de césarienne et motif de retard

Code couleur	Occupation du bloc	Difficulté financière	Incomplétude du kit	Manque de PSL	Retard de réalisation du bilan sanguin	Incomplétude du kit + Difficulté financière	Incomplétude du kit + manque de PSL	Total
Rouge	4	4	91	5	2	2	3	111
Orange	1	0	12	0	0	0	0	13
Vert	2	7	124	0	0	0	0	133
Total	**7**	**11**	**227**	**5**	**2**	**2**	**3**	**257**

Résultats

- Délai entre indication de césarienne et incision au bloc

  - délai moyen code vert : 130,58 ± 113,44 avec extrêmes de 14 et 720 min. (N<1h)

  - Code orange : 273,53 ± 296,97 avec extrêmes de 58 et 890 min

  - Code rouge :130,61 min ± 167,98 avec extrêmes 10 et 876 min.

(N <30 mn ⟶ code orange et < 15 mn pour code rouge)

Résultats

- Pronostic maternel

  - Durée moyenne de séjour était de 3,42 jours ± 1,04 avec des extrêmes de 2 et 12 jours.

  - Complications per- et post-opératoires : hémorragie per-opératoire représentait 3,55% des cas (10/282) et l'anémie 9,57% (27/282).

Résultats

- Pronostic périnatal

  - Taux de mortinaissance : 8,87% (25/282).

  - Morbidité néonatale : 12,06% (34/282) : Détresse respiratoire 42,12% (15/34), Prématurité 26,47% (9/34), Asphyxie néonatale, 17,65% (6/34)

Résultats

- Analyse multivariée facteurs associés à état du NN à la naissance

Indication de césarienne (code couleur)	Score d'Apgar à la 1ere min		OR	IC 95%	p-value
	< 7 min	≥ 7 min			
Code Rouge	35	153	3,34	1,778 ; 6,275	**0,000**
Code Orange	1	12	3,013	0,383 ; 23,687	**0,294**
Code Vert	15	81	0,317	0,171 ; 0,585	**0,000**
Délai de réalisation					
< 30 min	14	17	4,218	1,928 ; 9,224	**0,000**
30 - 60 min	12	54	1,969	1,082 ; 3,586	**0,027**
> 60 min	29	156	4,43	1,969 ; 9,966	**0,000**

Résultats

- Analyse multivariée des paramètres associés à la mortinaissance

Indication de césarienne (code couleur)	Mortinaissance		OR	IC 95%	p-value
	Oui	Non			
Code Rouge	16	9	2,791	1,187 ; 6,558	**0,019**
Code Orange	0	25	1		**0,000**
Code Vert	8	17	0,363	0,151 ; 0,872	**0,024**
Délai de réalisation					
< 30 min	10	21	0,133	0,053 ; 0,333	**0,000**
30 - 60 min	3	63	0,448	0,196 ; 1,024	**0,057**
> 60 min	12	173	0,145	0,056 ; 0,378	**0,000**

Conclusion

- Etude a montré un retard important entre la décision de césarienne et l'incision cutanée, quel que soit le degré le d'urgence.
- Il est donc essentiel d'introduire les codes couleurs dans notre pratique de travail afin d’améliorer pronostic périnatal.

Merci pour votre attention